



קבוצה	תרופות סדטיביות (בנזודיאזפין), תרופות לטיפול בפרכוסים
מנגנון הפעולה	דורמיקום הוא בנזודיאזפין בעל טווח פעולה קצר המשמש בעיקר לטיפול בפרכוסים, באינסומניה, בסדציה ובאמנזיה טרם ביצוע פעולות רפואיות שונות. דורמיקום מעלה ומשכר את השפעת הנירוטרנסמיטר GABA על הרצפטור GABAA האינהיבטורי. שפעול רצפטורי GABAA הוא למעשה הגורם למגוון ההשפעות של התרופה, כגון נוגד פרכוס, הרגעה, הרדמה, הפחתת חרדה, אמנזיה, הרפיית שרירים.
פרמקוקינטיקה	תחילת ההשפעה 2–3 דקות (מתן ב־I.V), 6–14 דקות (מתן ב־I.N/I.M). שיא ההשפעה לאחר 20–60 דקות. משך ההשפעה עד שעתיים. זמן מחצית חיים הוא 1–4 שעות.
התוויות לשימוש	פרכוסים; סדציה; הרגעת חולה אלים.
התוויות נגד	לחץ דם נמוך וסימני היפוכרפוזיה; גלאוקומה זוויתית חריפה; תרדמת.
תופעות לוואי	דיכוי נשימת; ירידה בלחץ הדם; ברדיקרדיה; כאבי ראש; בחילות והקאות.
מינון	לצורך השריית סדציה עמוקה (לקראת אינטובציה) – 0.1 mg/kg, מקסימום למנה בודדת 10 mg. לצורך השריית סדציה שטחית (לקראת היפוך חשמלי) – 2.5–5 mg, מתן ב־I.V, (לשקול מתן גם למטופל שקיבל קטמין). לצורך הרגעת מטופל המצוי בדליריום מבוגרים – 2.5–5 mg, מתן ב־I.V או 5 mg מתן ב־I.M. ילדים – 0.1 mg/kg מתן ב־I.V או 0.15 mg/kg מתן ב־I.M. לטיפול בפרכוסים במבוגר 5 mg, מתן ב־I.V, אפשר לתת מנות חוזרות כעבור 5–10 דקות עד להפסקת הפרכוס. אם לא הושגה גישה ורידית או תוך־לשדית אפשר להזריק I.M או I.N (10 mg). לצורך שימור סדציה – מנות חוזרות במינון של 2.5 mg ב־PUSH או 0.1–0.2 mg/min ב־Drip במינון 0.1–0.2 mg/min. לטיפול בפרכוס בילדים או להשריית סדציה בילדים – 0.1 mg/kg, מתן ב־I.V, מקסימום למנה בפרכוס – 5 mg. מקסימום למנה בסדציה – 10 mg. – 0.2 mg/kg, מתן ב־I.N/I.M, מקסימום למנה – 10 mg. – במקרה הצורך אפשר לתת מנה נוספת של דורמיקום (לאחר 5 דקות מתן ב־I.V, ולאחר 10 דקות מתן ב־I.M). – לשימור הסדציה – מנות חוזרות במינון של 0.05 mg/kg (מנה מקסימלית 2.5 mg) או Drip במינון – 0.01–0.06 mg/kg/hr.

Class D בעיקר בטרימסטר הראשון – מחקרים בבעלי חיים ובנשים הרות הראו נזק מוכח לעובר והתרופה אינה נחשבת לבטוחה לשימוש בהיריון. תיתכן נטייה לעלייה בשכיחות שפה שסועה. מתן של דורמיקום לאם זמן קצר לפני הלידה יכול לגרום להיפוך העובר. הנקה – התרופה עוברת בחלב האם אל התינוק לכן יש לנטר את התינוק. דורמיקום עלול לגרום הפרעה בייצור החלב לנשים מניקות.	בטיחות בהריון
I.V/I.M/I.N	צורות מתן במד"א
<u>ניהול מתקדם של נתיב האוויר</u>; <u>ניהול מתקדם של נתיב האוויר בתינוקות ובילדים</u>; <u>פרכוס או לאחר פרכוס במבוגר</u>; <u>פרכוס או לאחר פרכוס בתינוקות ובילדים</u>; <u>הטיפול בכאב</u>; <u>רעלת היריון (פרה־אקלמפסיה/אקלמפסיה)</u>; <u>לפני ביצוע היפוך חשמלי בפרוטוקול טכיקרדיה במבוגר</u>; <u>טכיקרדיה בתינוקות ובילדים</u>	מופיע בפרוטוקול